BC3 – Chapitre 19 : tout ce qu'il faut savoir

La veille et la lecture critique – fiche complète (à jour au 4 novembre 2026)

Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 19. Elle traite d'abord de la veille : définition, cycle, outils, plan de veille, alertes et flux, budget temps, ressources, sources primaires et secondaires, lecture d'un avis, d'une recommandation et d'une ligne directrice, base documentaire, note de veille, diffusion et évaluation. Elle traite ensuite de la lecture critique d'un article (relecture par les pairs, rétractation, revues prédatrices, registres, tableau 1, spin, conflits d'intérêts, presse), puis de l'exemple d'Inès, des approfondissements (désinformation, veille réglementaire, intelligence artificielle, niveaux de preuve), de la L3, des quatre cas guidés et du jury. Elle suit l'ordre du cours (19.3 à 19.8).

Compétences : **C3.4** (cœur : « assurer une veille scientifique, professionnelle et réglementaire »), C3.3 (recherche bibliographique), C3.5 (diffuser une synthèse adaptée), C3.6 (outils numériques). Référentiel : **arrêté du 27/11/2024** (JO du 17/12/2024) ; guide 2025, **p. 66-67** (« démarche de veille », « outils et techniques de lecture critique »). Le CNED **ne traite pas** la veille documentaire ni la lecture critique (savoirs nouveaux du référentiel 2024) ; il présente les organismes (Synthèse M1 S1 p. 3-4 et S2 § 3 p. 6 ; Essentiels S3 § 1.6 p. 14-15) et la **veille sanitaire** (Essentiels S1 § 4 p. 4), à ne pas confondre avec la veille documentaire.

Corrections du fascicule CNED à appliquer :

- **INRA** : depuis le **1/1/2020**, l'INRA a fusionné avec l'Irstea pour former l'**INRAE**.
- **ANSES et PNNS** : l'ANSES n'« actualise » pas le PNNS. Elle rend des **avis scientifiques** (repères de consommation, 2016). Le programme est piloté par le **ministère chargé de la santé**, et **Santé publique France** a publié les repères de **2019**. Programme en vigueur : **PNNS 5 (2026-2030), lancé le 8/4/2026**.
- **Veille sanitaire** : elle n'est pas « propre à chaque département ». Elle est assurée au niveau **national par Santé publique France** et **en région par les ARS** (l'OMS au niveau mondial).

Autres précisions : les exemples chiffrés du cours sont **fictifs** sauf mention ; les études citées comme réelles (Boutron 2010, Sumner 2014, Lundh 2017, aspartame 2023, Wakefield) ont été vérifiées. La grille **CONSORT** citée par le cours (version 2010) a été **mise à jour en avril 2025 (CONSORT 2025)** : citer la version la plus récente. Petite coquille du cours : en 19.3.2, la phrase sur le PNNS 5 est écrite deux fois.

1. La veille : définition, cycle, outils (19.3.1)

Veille : activité **continue et organisée** de surveillance de l'environnement pour **repérer** les informations utiles, les **analyser** et les **diffuser** aux personnes qui en ont besoin, afin d'**anticiper et de décider**. **Formes** : **scientifique** (études, avis de l'ANSES) ; **réglementaire** (EGalim, étiquetage, allégations) ; **professionnelle** (HAS, AFDN) ; **sociétale** (régimes à la mode, réseaux sociaux) ; **institutionnelle** (PNNS, appels à projets) ; **technologique** (logiciels, applications, matériel).

Le cycle de la veille (7 étapes) : **besoins → sources → collecte → tri et analyse → stockage → diffusion → évaluation** (puis on recommence).

Outils : mode **pull** (on va chercher : moteurs, bases, sites de référence) et mode **push** (l'information arrive : **alertes** par mots-clés, **flux RSS** lus dans un **agrégateur**, **lettres d'information**, listes de diffusion). Une veille efficace combine les deux, avec un temps de tri régulier (30 min par semaine).

Veille ≠ recherche documentaire ≠ bibliographie :

- La **veille** est **continue** : elle repère les nouveautés avec des outils push et produit une base et des notes.
- La **recherche documentaire** est **ponctuelle** : elle répond à **une question** avec une équation dans des bases.
- La **bibliographie** liste les documents **cités**, au moment de rédiger.

Lire chaque matin les actualités n'est **pas** une veille (information « au fil de l'eau »).

Axe de veille : sujet surveillé dans la durée. **Question de veille** : ce que l'on veut savoir, **pour qui**, **pour quoi faire**. Elle évite de tout collecter.

Plan de veille : c'est un tableau, relu **chaque trimestre**. Ses rubriques : axe, question, forme, sources, outils, fréquence, destinataires, temps, indicateur. On le construit en **7 étapes** :

1. Recueillir les besoins de l'équipe.

2. Choisir **3 à 5 axes**.
3. Écrire une question par axe.
4. Choisir **2 à 4 sources par axe** (une institutionnelle, une professionnelle, une scientifique).
5. Fixer les outils et la fréquence (push si possible).
6. Calculer le temps, en gardant une marge pour le rangement et la diffusion.
7. Prévoir l'évaluation (1-2 indicateurs, une date de bilan).

Exemple : une cuisine centrale de 1 800 repas dispose d'une heure par semaine. Elle répartit 15 + 15 + 10 min sur trois axes et garde 20 min pour ranger et diffuser. **En stage** : 3 sujets, 5-8 sources, 2 alertes, tri chaque semaine, tableur, note mensuelle, bilan en fin de stage.

Alerte PubMed : recherche enregistrée que la base relance seule. Méthode :

1. Tester la requête ([ti] pour le titre, [tiab] pour le titre et le résumé, [mh] pour les mots-clés MeSH).
2. Regarder le nombre de résultats par an.
3. Créer un compte **My NCBI**.
4. Cliquer sur « **Create alert** » et choisir la fréquence.
5. Vérifier au bout d'un mois.

PubMed propose aussi « Create RSS ». **Bruit** = documents reçus mais inutiles ; **silence** = documents utiles non reçus. Restreindre une alerte réduit le bruit mais **augmente le silence**. Exemple : 1 340 résultats sur 5 ans = 268 par an, soit environ 5,2 par semaine ; avec le titre seul, environ 1,6 par semaine.

Budget temps (le danger, c'est la **surcharge**). Inès reçoit 120 informations en 13 semaines et en garde 30 :

Poste	Calcul	Minutes par semaine
Titres	9,2 × 0,5	4,6
Résumés	2,3 × 5	11,5
Rangement	2,3 × 2	4,6
Note mensuelle	45 × 12 / 52	10,4
Total		**≈ 31**

Règle des 3 piles, à **heure fixe** :

- **Supprimer** : hors sujet ou source douteuse.
- **Garder** : intéressant, sans usage prévu.
- **Diffuser** : ce qui change une pratique.

Se désabonner d'une source qui n'a rien apporté depuis 3 mois. Exercice : 60 titres × 0,5 + 6 × 4 + 6 × 2 = 66 min ; pour tenir en 45 min, il faut recevoir 42 informations de moins, soit 18 par semaine.

La veille sert le projet : diagnostic, objectifs, actions, **financement** (appels à projets), évaluation, communication. Dans le dossier E5, une partie « **Ma veille** » montre les axes, les sources, un extrait de la base, une note et deux informations utilisées.

Exemples :

- **Pédiatrie** : 1 h 30 par semaine (20 + 20 + 15 + 10 + 25 min pour le rangement et la diffusion). Les informations des **fournisseurs** sont des sources commerciales, à vérifier.
- **Libéral** : 10 min par jour, soit 50 min par semaine et environ 37 h par an. On ajoute un groupe de pairs chaque trimestre.

Veille technologique : logiciels (quelle version de Ciqual ?), applications (où sont hébergées les données ? quelle base alimentaire ? messages culpabilisants ?), téléconsultation. Une application **n'est pas un dispositif validé**.

Veille sanitaire ≠ veille documentaire :

- La **veille sanitaire** sert à **donner l'alerte**. Elle est assurée par Santé publique France et les ARS.
- La **veille documentaire** sert à tenir ses connaissances à jour (compétence C3.4).

Les deux suivent le même cycle.

2. Les ressources et les documents (19.3.2-19.3.3)

Ressources par niveau :

Niveau	Ressources
International	**OMS**, **FAO**, **Codex Alimentarius** (normes FAO/OMS)
Européen	**EFSA** (créée en **2002**, règlement (CE) 178/2002), Commission européenne
National	**ANSES**, **Santé publique France**, **HAS**, **Drees**, ministères, **HCSP**
Professionnel	**AFDN**, sociétés savantes (SFN, SFNCM), revues, congrès

Les textes se trouvent sur **Légifrance** et **EUR-Lex**. Toujours noter la **date de version**.

Sources primaires, secondaires, tertiaires :

- **Primaire** : le document qui produit l'information (article d'étude, texte de loi, données). On le cite.
- **Secondaire** : un document qui analyse des sources primaires (revue systématique, avis d'agence, recommandation). C'est la **source de choix**.
- **Tertiaire** : un document qui résume ou vulgarise (manuel, presse, fiche grand public). On ne l'utilise **jamais seul pour décider**.

La presse professionnelle sert à repérer ; on vérifie ensuite dans la source. **Remonter en 3 clics** : nom de la revue ou de l'auteur → PubMed → résumé et conclusion. Si l'on ne retrouve pas l'étude, **on ne diffuse pas**.

Lire un avis de l'ANSES en 15 min : 1 la **saisine** (la question posée) ; 2 les **conclusions et recommandations de l'agence** ; 3 les limites ; 4 l'organisation de l'expertise (liens d'intérêts) ; 5 la **date**. À l'EFSA, les avis paraissent dans l'**EFSA Journal**. **Un avis n'est pas une loi** : on écrit « l'ANSES **recommande** », jamais « interdit ».

Danger ≠ risque : le **danger** est la capacité à nuire, quelle que soit la dose ; le **risque** est la probabilité de nuire à une exposition donnée. **DJA** (additif, par kg de poids, toute la vie) ; **LSS** (limite pour un nutriment). **Aspartame, 14/7/2023** : le **CIRC** (danger) le classe « peut-être cancérogène » (**groupe 2B**) ; le **JECFA** (risque) maintient la **DJA de 40 mg/kg/j**, soit 2 800 mg pour 70 kg et 800 mg pour 20 kg. Les deux avis ne se contredisent pas.

Une recommandation de bonne pratique de la HAS comprend :

- la **fiche de synthèse**, qui sert à la note de veille ;
- le **texte des recommandations**, avec leurs grades, qui sert à mettre à jour un protocole ;
- l'**argumentaire scientifique**, qui sert à répondre à une contestation ;
- les **outils associés**.

On donne le **grade** (A ≠ accord d'experts).

Repères 2019 (Santé publique France), fondés sur l'ANSES 2016 et le HCSP 2017 :

- **2 produits laitiers** par jour pour les adultes, au lieu de 3 ;
- **légumes secs au moins 2 fois par semaine** ;
- une poignée de **fruits à coque** par jour ;
- viande hors volaille **≤ 500 g** par semaine ; charcuterie **≤ 150 g** par semaine ;
- féculents complets ;
- « 5 fruits et légumes » conservé.

Une recommandation qui change **n'était pas « fausse »**. Les repères des personnes âgées peuvent différer.

Lignes directrices de l'OMS : recommandation **forte** (« l'OMS recommande ») ou **conditionnelle** (« l'OMS suggère »). Exemples :

- **Sucres, 2015** : forte pour **< 10 %** de l'énergie, conditionnelle pour **< 5 %**.
- **Édulcorants, 2023** : recommandation conditionnelle de **ne pas les utiliser pour contrôler le poids**.

L'OMS **n'interdit** rien.

Lettres d'information : 6 critères (producteur, lien avec les axes, rythme, sources citées, **indépendance**, doublon). Exemple : la lettre A apporte 7 informations utiles sur 18 (38,9 %), la lettre B 5 sur 24 (20,8 %), la lettre C 0 % d'apport propre → on se **désabonne de C**. Une lettre éditée par une marque sert à repérer des sujets, **pas comme preuve**.

Instances consultatives : **HCSP** (expertise pour le ministère), **CNA** (Conseil national de l'alimentation, concertation des acteurs), **CESE**, commissions parlementaires. Elles **annoncent les textes futurs**.

Composition des aliments : **Ciqual** (ANSES ; noter la **version**, ici 2025) ; **Oqali** (INRAE et ANSES ; par famille de produits, pas par marque) ; étiquette (tolérances). **Une valeur sans version n'est pas vérifiable.**

Nouvel aliment : aliment non consommé de façon significative dans l'UE **avant le 15/5/1997**. Il faut une évaluation de l'**EFSA** et une autorisation de la Commission : **règlement (UE) 2015/2283, applicable depuis le 1/1/2018**. Exemple : la larve séchée de **ver de farine** (règlement d'exécution (UE) **2021/882 du 1/6/2021**), avec une mention d'**allergie croisée** (crustacés, mollusques, acariens).

Base documentaire : dossier, **tableur** (date, source, titre, mots-clés, résumé, lien, usage) ou **Zotero**. Elle est stockée dans l'**espace sécurisé** de la structure, dans le respect du **droit d'auteur** (lien plutôt que copie).

Mots-clés : utiliser une **liste fermée** (20-30 termes, menu déroulant, un responsable) ou un **thésaurus** (un **descripteur** par idée, des renvois depuis les synonymes). **MeSH** = thésaurus de PubMed (version bilingue à l'Inserm).

Entretien de la base :

Problème	Parade
Doublons	champ **DOI** obligatoire
Liens morts	lien **doi.org**
Recommandation dépassée	champ **statut** (en vigueur, remplacé, retiré)
Article rétracté	vérifier le statut avant de rediffuser

Le **DOI** commence par « **10.** » et il est **unique et permanent**. Exemple : 24 + 18 + 9 = 51 fiches à reprendre sur 300, soit **17 %**.

Durée de conservation :

- texte en vigueur : tant qu'il s'applique, puis on l'archive avec la mention « **remplacé** » (on ne le supprime pas : traçabilité) ;
- information jamais utilisée : 2-3 ans ;
- tendance : 1-2 ans ;
- données personnelles : **à supprimer**.

Messagerie : un dossier « Veille », des **règles de tri**, un agrégateur, une lecture à heure fixe, puis on vide le dossier.

Accès légal aux articles : accès libre (« Free full text »), **PubMed Central**, **HAL**, demande à l'auteur, bibliothèques. Les **sites pirates** sont **interdits** (droit d'auteur, sécurité).

3. Diffuser et évaluer (19.3.3)

Diffusion ciblée : qui en a besoin ? quoi (l'essentiel, la source datée, « **ce que cela change pour nous** ») ? comment ? quand (chaque mois, ou **immédiatement** si c'est urgent) ? On ne transfère **jamais d'articles entiers sans commentaire**.

Note de veille d'une page :

- en-tête ;
- **3 à 5 informations**, de la plus importante à la moins importante. Chacune comporte un **titre court qui dit l'essentiel**, 2-3 lignes avec **un chiffre au plus**, la **source datée** et « ce que cela change pour nous » (une action, ou « pour information ») ;
- une rubrique « à venir » ;
- le contact et le lien vers la base.

À éviter : « récemment », « prouve », « interdit », un lien sans commentaire, dix pièces jointes. Exemple : **EGalim, modifiée par la loi Climat et résilience** : au moins **50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de bio**.

Matrice de diffusion : un tableau qui croise les axes et les destinataires (qui reçoit quoi, et quand).

Information urgente (rappel d'un produit servi, alerte, texte vite applicable, date limite) : on prévient **par téléphone puis par écrit**. Dispositifs :

- **RappelConso** (rappels de produits en France) ;
- **RASFF** (alerte rapide de l'UE) ;
- **nutrivigilance de l'ANSES** (loi **HPST du 21/7/2009**). Le diététicien **peut et doit** déclarer un effet indésirable lié à un complément.

Partager avec le public : affiche « l'info du mois », une seule idée, la source en bas. On ne diffuse **ni preprint, ni information non vérifiée, ni information qui pousserait à arrêter un traitement, ni rumeur** que le public ne connaît pas.

Présenter à l'oral en 5 minutes : période et axes ; **3 informations au plus** ; ce qui est à surveiller ; une décision ; les questions. Un chiffre par information, dit en **fréquence naturelle** (« 3 sur 100 »), avec la source et l'année dites à voix haute.

Évaluer (Inès) :

Indicateur	Calcul	Résultat
Pertinence de la collecte	30 retenues / 120 reçues	**25 %**
Diffusion	12 diffusées / 30 retenues	40 %
Utilisation	5 utilisées / 12 diffusées	41,7 %

Trois sources sur 8 fournissent 80 % des informations retenues : on ajuste.

Coût : 3 personnes × 40 min × 46 semaines = 92 h, × 35 € = 3 220 € ; avec l'abonnement, 3 460 €, soit **192 € par information utilisée**. On le compare à ce que la veille **évite** (protocole périmé, obligation découverte trop tard, financement manqué). Trois types d'indicateurs : **moyens, activité, résultats**.

Veille collective :

- les étapes : inventaire, suppression des abonnements en double, répartition des axes, **outil unique** avec la même liste de mots-clés, rendez-vous, coordinateur ;
- l'effet : 6 × 30 min au lieu de 6 × 60, soit **180 min gagnées** par semaine ;
- la condition : des **règles de saisie** écrites.

Avis des destinataires : 26 répondants sur 40 (65 %). La note est lue (76,9 % d'accord) et jugée utile (69,2 %), mais sa longueur ne convient qu'à 46,2 % → **la raccourcir**. La moyenne seule ne suffit pas : on donne aussi la **répartition**.

Tableau de bord : de T1 à T4, la pertinence passe de 13,5 % à 18,9 %, l'utilisation de 26,7 % à 56,3 %, et le temps par information utilisée de 390 à 113 min. Sur l'année : 15,5 % ; 41,7 % ; **204 min**.

4. La lecture critique d'un article (19.3.4)

Revue à comité de lecture : la relecture par les pairs est un filtre utile mais imparfait. Les relecteurs **ne refont pas l'étude** et ne voient pas les données brutes. La relecture peut être en simple aveugle, en double aveugle ou ouverte. **Grilles de rédaction** : **CONSORT** (essais ; version **2025**), **STROBE** (études observationnelles), **PRISMA** (revues systématiques).

La grille de lecture en 6 rubriques (guide 2025) :

1. **Objet et question** : claire, pertinente, nouvelle ?
2. **Méthodologie** : type d'étude, population, outils validés, biais et confusion, éthique.
3. **Résultats** : effectifs, %, **IC**, tableaux lisibles.
4. **Discussion** : prudente, comparée, **limites** reconnues.
5. **Applications** : est-ce **transposable** à mon public et à mon contexte ?
6. **Forme et source** : revue, date, auteurs, **financement**, **conflits d'intérêts**, références récentes.

Signaux d'alerte : titre spectaculaire ou causal pour une étude d'observation ; très petit effectif ; pas d'IC ; aucune limite citée ; financement non déclaré.

Preprint (par exemple medRxiv) : manuscrit mis en ligne **avant relecture**. On le signale comme « résultat provisoire » et on ne le diffuse **pas au public**.

Notices :

Notice	Ce qu'elle veut dire	Ce que l'on fait
Erratum	une erreur ponctuelle est corrigée	on corrige la fiche
Expression de préoccupation	un doute sérieux, une enquête est en cours	on suspend l'usage
Rétractation	l'article est retiré	on ne l'utilise plus ; on marque la fiche ; on corrige les documents qui le citent

PubMed signale « Retracted Publication » ; la base **Retraction Watch** est gratuite via **Crossref depuis 2023**. Exemple : l'article de **Wakefield** (The Lancet, **1998**, vaccin ROR et autisme), **rétracté en 2010**, circule encore. Si un article diffusé est rétracté, on corrige **d'abord la fiche patient**.

Revue prédatrice : publie contre paiement sans vraie relecture. Signaux : courriels flatteurs, **délai très court**, frais mis en avant, titre « fourre-tout », comité éditorial introuvable, **absence d'indexation** (MEDLINE, **DOAJ**) ou faux facteur d'impact. Outils : DOAJ, « Think. Check. Submit. ». **Accès libre ≠ prédatrice.**

Registres d'essais : les grandes revues exigent l'enregistrement **depuis 2005**, **avant le premier participant**. Registres : **ClinicalTrials.gov** (États-Unis), **ICTRP** (OMS), **CTIS** (UE). Ils permettent de vérifier le critère principal, l'effectif et la publication. Le **changement de critère principal** (outcome switching) est un signal d'alerte (exemple : un essai prévu sur le poids à 6 mois est publié sur la satiété à 4 semaines).

Trois questions par type d'étude, et le bon verbe :

Type	Questions	Verbe
Revue systématique	recherche complète ? études de qualité ? cohérence ?	« une synthèse de N études… »
Essai randomisé	critère principal ? perdus de vue ? intention de traiter ?	« **réduit** »
Cohorte	confusion ? risque absolu ? durée du suivi ?	« **est associé à** »
Animal, laboratoire	dose ? modèle ?	« **chez la souris** » (aucun conseil)

Tableau 1 : on le lit **avant les résultats**, pour vérifier que les groupes sont **comparables au départ**. Exemple : des volontaires avec 78 % de femmes et 61 % de diplômés contre 52 % et 34 % → groupes différents. Le tirage au sort rend les groupes comparables.

Discussion : le critère principal doit venir d'abord ; les études contraires doivent être citées ; les limites doivent être précises ; un mécanisme reste une **hypothèse** ; pas de généralisation à « tous ». **Limites non dites** à chercher : qui manque ? qu'est-ce qui est déclaré ? quelle durée ? quelle autre explication ? qui finance ?

Cochrane : on y trouve un résumé en langage simple (souvent traduit), la **certitude des preuves** (élevée, modérée, faible, très faible) et la date de la recherche. Une **revue vivante** est mise à jour en continu. « **Preuves insuffisantes** » ≠ « inefficace » : on écrit « on ne sait pas encore ».

Congrès : résumé, poster, conférence invitée (opinion d'expert), **symposium satellite** (financé par une entreprise). On les classe « à suivre » et on vérifie un an plus tard ; on ne change **jamais un protocole sur un poster**.

Pourquoi les études de nutrition se contredisent :

- la mesure est déclarée ;
- la **substitution** : l'effet dépend de ce que l'aliment remplace ;
- les populations sont différentes ;
- les doses aussi (relation en U) ;
- les critères aussi (un marqueur n'est pas une maladie) ;
- les effets sont faibles.

Études précliniques : espèce, dose, régime extrême, mode d'administration, petit effectif. **Conversion d'une dose selon la surface corporelle** (FDA, 2005) : facteur 3 pour la souris, 37 pour l'humain. 200 mg/kg × 3 / 37 ≈ **16,2 mg/kg**, soit environ 1 g par jour pour 60 kg, et non 12 g.

Conflit d'intérêts : un intérêt secondaire qui peut influencer le jugement. Il doit être **déclaré** et pris en compte, mais il ne rend **pas** l'étude fausse. Un **lien d'intérêts** (une relation) devient un **conflit** quand il porte sur le sujet traité. **Avoir des liens n'est pas une faute ; les cacher en est une.** Où chercher :

- la base **Transparence Santé** ;
- les **déclarations publiques d'intérêts** des experts de l'ANSES et de la HAS ;
- la rubrique « Financement » de l'article.

Exemple : 3 × 450 € d'une interprofession laitière + 2 × 40 € → 1 430 €, dont **94,4 %** liés au sujet.

Effet du financement : Lundh et coll. (Cochrane, 2017, MR000033). Les études financées par l'industrie présentent plus souvent des **résultats favorables (RR 1,27 [1,17 ; 1,37])** et des **conclusions favorables (RR 1,34 [1,19 ; 1,51])**. Les leviers : le **comparateur** (comparer à « rien » ou à de l'eau), un **critère intermédiaire** (un marqueur sanguin), une **durée courte**, la non-publication des résultats décevants. Un communiqué, un « livre blanc » ou une « étude » de marché ne sont **pas des preuves**.

Spin (embellissement) : Boutron et coll. (JAMA, 2010) ont étudié 72 essais dont le critère principal n'était pas significatif. Le spin apparaissait dans **18 %** des titres, **37,5 %** des résultats du résumé et **58,3 % des conclusions du résumé**. Ses formes : mettre en avant un critère secondaire, un sous-groupe, une « tendance » (p = 0,08), conclure à

l'efficacité. **Pour y résister** : trouver le critère principal dans les Méthodes, lire son résultat, puis **réécrire la conclusion soi-même**.

Du communiqué au titre de presse : Sumner et coll. (BMJ, 2014) ont étudié 462 communiqués :

- **40 %** contenaient un conseil plus direct que l'article ;
- **33 %** un lien de cause plus fort ;
- **36 %** passaient de l'animal à l'humain.

Quand le communiqué exagérait la cause, la presse l'exagérait dans **81 %** des cas, contre 18 % sinon (**4,5 fois** plus souvent).

Six questions devant « une étude montre que… » :

1. **Quelle étude ?** Si on ne la retrouve pas, on s'arrête.
2. **Chez qui ?**
3. **Quel type ?**
4. **Combien ?** (relatif ou **absolu**)
5. **Comparé à quoi ?**
6. **Qu'en disent les autres ?**

Exemple : « les œufs doublent le risque » = de 2 à 4 cas pour 1 000 en 5 ans, dans une cohorte isolée.

Communiquer l'incertitude : « on sait que » (preuves fortes) ; « probablement » (modérées) ; « quelques études suggèrent » (faibles) ; « aucune étude sérieuse ne montre » (pas de preuve). On dit toujours **ce que l'on fait en attendant**.

5. L'exemple d'Inès (19.3.5)

Dispositif : 3 sujets (petit budget, légumineuses, précarité alimentaire et numérique) ; sources SpF, ANSES, mangerbouger.fr, Drees, AFDN ; 2 alertes ; un tableur partagé avec la tutrice ; une note mensuelle d'une page. Elle a lu un article sur des ateliers (avant-après, **sans groupe témoin**, 45 familles, données déclarées) et le cite comme « **une expérience proche** », pas comme une preuve.

Ce qu'elle a écarté : une « étude » introuvable ; un **preprint** (gardé « à suivre ») ; une vidéo virale (rangée en veille sociétale). Elle a transmis l'**appel à projets** à la directrice **avant** la note, à cause de la date limite.

Le titre « lentilles − 20 % de cholestérol » : il s'agit d'un essai de 6 semaines sur 48 adultes. Le LDL baisse d'environ **8 %** ; les 20 % viennent d'un **sous-groupe**.

La rumeur sur les conserves : Inès suit SIFT, puis répond **oralement**, sans affiche (**ne pas amplifier**), après avoir vérifié le texte sur Légifrance.

Bilan : 13 × 30 = 390 min, pour 5 informations utilisées, soit **78 min par information**. Elle garde 5 sources sur 8, confie la veille à l'animatrice (20 min par semaine) et propose une « info du mois » affichée.

6. Approfondissements (19.4)

Infodémie (OMS) : surabondance d'informations, vraies ou fausses.

Lecture latérale : quitter la page et vérifier dans d'autres onglets (≠ lecture verticale, qui juge la page sur son apparence).

Méthode SIFT (Caulfield, 2019) :

- **S**top : s'arrêter avant de lire ou de partager ;
- **I**nvestigate the source : enquêter sur qui publie ;
- **F**ind better coverage : chercher une meilleure source ;
- **T**race claims : remonter à l'origine.

Le logo, les photos et les témoignages **ne sont pas des critères de fiabilité**.

Contenus trompeurs :

- **Images** : on fait une **recherche d'image inversée** pour trouver la première apparition (date, lieu, contexte).
- **Faux sites et vidéos** : un médecin connu peut être imité par un logiciel. Les malades chroniques sont des cibles. Le message à donner : **« n'arrêtez jamais votre traitement »**, et signaler le contenu.

Veille sociétale : elle cherche des **tendances, des idées reçues et des inquiétudes**, pas des preuves. Sources : questions reçues, mots-dièses, Google Trends (indice relatif). Règles :

- **ne pas amplifier** une rumeur ;
- ne jamais enregistrer de **données personnelles**.

Exemple : 6 adolescents sur 24 (25 %) parlent du « régime carnivore » → c'est un signal à suivre. Les **forums de patients** renseignent sur leurs difficultés, pas sur la fréquence d'un problème ni sur l'efficacité d'un produit.

Titres :

- **Diététicien** : profession de santé **réglementée** (Code de la santé publique), à vérifier dans l'**Annuaire santé**.
- **Médecin** : inscrit à l'Ordre.
- **« Nutritionniste » seul**, coach, nutrithérapeute, naturopathe : titres **non protégés**.

Un titre protégé ne garantit pas l'information.

Veille réglementaire : **texte publié ≠ texte applicable**. On lit la **version consolidée** sur Légifrance. Sur EUR-Lex, **seule la publication au JOUE fait foi**. Un **règlement** européen s'applique directement ; une **directive** doit être transposée. Méthode : numéro et date du texte → version consolidée à la date du jour → article précis et dates d'application → textes d'application → noter dans la base.

Textes clés :

Texte	Objet	Dates
(CE) 1924/2006	allégations	applicable le 1/7/2007
Décret 2006-352 du 20/3/2006	compléments alimentaires	
(UE) 1169/2011 « INCO »	étiquetage, allergènes	applicable le **13/12/2014** ; déclaration nutritionnelle obligatoire le **13/12/2016**
Décret 2011-1227 et arrêté du 30/9/2011	repas scolaires	
(UE) 432/2012	allégations de santé autorisées	publié le 25/5/2012 ; applicable le 14/12/2012 (203 jours)
(UE) 2015/2283	nouveaux aliments	applicable le 1/1/2018
Loi **2018-938** du 30/10/2018 (EGalim)	restauration collective	50 % dont 20 % de bio au 1/1/2022
(UE) 2018/848	bio	applicable le 1/1/2022
Loi 2020-105 (**AGEC**)	gaspillage, économie circulaire	
Loi **2021-1104** du 22/8/2021 (Climat et résilience)	renforce EGalim	restauration collective privée au 1/1/2024

Calendrier de conformité : date d'alerte = échéance − temps d'adaptation − marge. Exemple : un marché de 7 mois + 1 mois de marge pour le 1/9 → prévenir au plus tard le **1/1**.

Veille institutionnelle : ARS, collectivités, caisses, **conférence des financeurs** (perte d'autonomie), fondations. On transmet un appel à projets **immédiatement**. Exemple : 80 % de 22 500 € = 18 000 € (plafond), reste 4 500 €.

Normes volontaires : **ISO 22000** (sécurité des denrées) ; **NF V94-001 (2012)** (produits pour sportifs sans substances dopantes). Elles deviennent exigibles si un contrat les cite. On suit aussi les **consultations publiques** (EFSA, Commission).

Intelligence artificielle : un outil d'IA peut **inventer des références** (« hallucination »). **Vérification en 4 étapes** :

1. le **DOI** ;
2. le **titre exact** entre guillemets dans PubMed ;
3. la **concordance** (revue, année, auteurs) ;
4. le **contenu** (lire au moins le résumé).

Exemple : 3 références utilisables sur 8 (37,5 %) et 2 inventées (25 %). **Jamais de données de patients** ni de documents confidentiels dans un outil d'IA grand public (secret professionnel, RGPD, DPO).

Niveaux de preuve dans une note :

Document	Formulation
Recommandation	« la HAS recommande (grade B) »
Revue systématique	« une synthèse de N études »
Essai randomisé	« dans un essai chez N personnes »
Cohorte	« une association »

Document	Formulation
Animal	« chez l'animal… ; pas de conclusion chez l'humain »
Avis d'expert, témoignage	le niveau le plus faible ; pas une preuve

La **transposabilité** se juge sur 4 points : population, contexte, faisabilité, acceptabilité.

Sources en désaccord :

1. faire un tableau (source, type, population, résultat, limites, financement) ;
2. classer par niveau de preuve ;
3. expliquer les désaccords ;
4. conclure prudemment.

Exemple : un essai de 4 semaines sur 30 personnes pèse moins qu'un essai de 12 mois sur 600.

Synthèse rapide en 1 h :

Étape	Durée
Reformuler la question	5 min
Recommandations et revues systématiques d'abord	15 min
Chercher plus récent	20 min
Rédiger une demi-page	15 min
Indiquer les limites	5 min

Protocoles : les dater, les réviser tous les **3 ans** (ou plus tôt si la veille l'impose), retirer l'ancienne version. La veille est une **obligation professionnelle** : **DPC** sur des périodes de **3 ans**.

7. Niveau L3 (19.5)

Facteur d'impact : il mesure la visibilité d'une **revue**, pas la qualité d'un article (déclaration **DORA, 2012**). **Science ouverte** : HAL, plans nationaux.

Ioannidis (PLoS Medicine, 2005), « Why most published research findings are false » : un résultat significatif a moins de chances d'être vrai si les études sont petites, les effets faibles, les hypothèses nombreuses, les méthodes flexibles, le sujet à la mode ou porté par des intérêts financiers. C'est la **crise de la reproductibilité**.

GRADE : la certitude est élevée, modérée, faible ou très faible.

- Point de départ : **essais = élevée** ; **observation = faible**.
- **5 critères pour abaisser** : risque de biais, incohérence, caractère indirect, imprécision, biais de publication.
- **3 critères pour élever** (études d'observation) : effet très important, relation dose-effet, confusion qui irait contre l'effet.

Exemple : des essais (élevée) avec deux défauts donnent une certitude faible → on écrit « pourrait ».

Indice h (Hirsch, 2005) : h = 20 veut dire que 20 articles ont été cités au moins 20 fois chacun. **Altmétrie** : elle mesure l'attention reçue, **pas la solidité**.

8. Cas guidés, jury, à retenir (19.6-19.8)

Cas 1 – compléments dans un club de cyclisme (64 adhérents) :

- **L'urgence d'abord** : le coureur voit un médecin et l'effet est **déclaré à la nutrivigilance**, avec son accord.
- **L'enquête** : 22 coureurs prennent un complément (34,4 %) ; 9 d'entre eux achètent hors UE (40,9 % des consommateurs) ; 14 n'en ont parlé à aucun professionnel (63,6 %).
- **La réglementation** : décret 2006-352 ; « brûle les graisses » est absent des allégations autorisées (432/2012) ; NF V94-001.
- **La diffusion** : une affiche « 3 réflexes » et une soirée de 45 min.

Cas 2 – jeûne intermittent (16/8) : essai sur 60 adultes en surpoids pendant 12 semaines.

- Résultats : − 4,1 kg contre − 3,6 kg, différence **0,5 kg [− 0,8 ; 1,8]**. L'IC **contient 0** : pas de différence.
- Perdus de vue : 20 % contre 10 %.
- La conclusion « efficace » est du **spin** ; le titre de presse ajoute « sans compter les calories » et « prouve ».
- Réponse : le jeûne fait perdre **à peu près autant** qu'une réduction des apports.

Cas 3 – PMI et diversification : 46 questions pour 180 familles (25,6 %), dont 31 sur les allergènes (67,4 %). **Repères 0-3 ans de Santé publique France (2021)** :

- diversification **entre 4 et 6 mois** ;
- **ne pas retarder les allergènes** (œuf, arachide sous forme adaptée, poisson), même chez les enfants à risque, avec le médecin.

« Attendre un an pour l'œuf » est un conseil **abandonné**. Actions : une note, une réunion, une réponse type ; on mesure ensuite la cohérence de l'équipe.

Cas 4 – cuisine centrale de Valbrune : achats de 420 000 €. Produits durables : 186 000 € = **44,3 %** (objectif 50 %). Bio : 71 400 € = **17,0 %** (objectif 20 %). Il manque 24 000 € et 12 600 €. Avec + 30 000 € de bio : **51,4 % et 24,1 %**. Source : version consolidée d'EGalim (Code rural et de la pêche maritime). Les marchés publics demandent plusieurs mois.

Analyser un document à l'E5 (6 points) :

1. Identifier le document (nature, auteur, date, primaire ou non).
2. Dire de quoi il parle.
3. Juger la source.
4. Juger le contenu (type, population, chiffres absolus, critère principal, limites).
5. Comparer aux références.
6. **Conclure** : ce que l'on en fait.

Chaque point suit la forme constat → conséquence → proposition. On commence **par les qualités**. Exemple : « le régime cétogène guérit la migraine » repose sur 35 patients, 2 mois, sans témoin → « à suivre », pas de diffusion.

Le jury attend :

- une veille **organisée** (axes, sources, temps) ;
- des sources **datées** ;
- une **lecture critique** (type, critère principal, limites, intérêts) ;
- des **verbes justes** ;
- une diffusion utile (« ce que cela change ») ;
- une **évaluation chiffrée** ;
- un **lien avec l'action**.

Erreurs fréquentes :

- « J'ai fait une veille sur Google » ;
- « d'après une étude… » sans auteur ni date ;
- « INCO oblige depuis 2011 » (en fait depuis le 13/12/2014) ;
- « prouve » pour une cohorte ;
- « + 50 % » sans chiffre absolu ;
- « le site est bien fait » ;
- « l'ANSES interdit » ;
- une référence d'IA non vérifiée ;
- un preprint diffusé au public ;
- un démenti qui amplifie la rumeur.

Dix règles :

1. Écrire les axes avant de s'abonner.
2. Choisir peu de sources.
3. Utiliser le push et le tri automatique.
4. Trier à heure fixe, en 3 piles.
5. Ranger avec la référence, la date et la liste fermée.
6. Remonter à la source.
7. Utiliser le bon verbe et des chiffres absolus.
8. Diffuser peu, ciblé et daté.
9. Distinguer la date du texte et sa date d'application.
10. Évaluer chaque trimestre.

Bibliographie utile :

- Lesca (2003) ;

- AFNOR XP X50-053 (1998) ;
- Greenhalgh, How to Read a Paper (2019) ;
- Salmi, Lecture critique (2012) ;
- CONSORT, STROBE (Lancet, 2007), PRISMA 2020 (BMJ, 2021) ;
- règlement (CE) 178/2002 ;
- Transparence Santé ;
- ICMJE.